KBV KASSENÄRZTLICHE BUNDESVEREINIGUNG

HYBRID-DRG

51. DEUTSCHER KOLOPROKTOLOGEN-KONGRESS AUGSBURG AM 15. MÄRZ 2025



ANNA MARIA RASKOP
ABTEILUNGSLEITERIN MEDIZINISCHE DOKUMENTATION

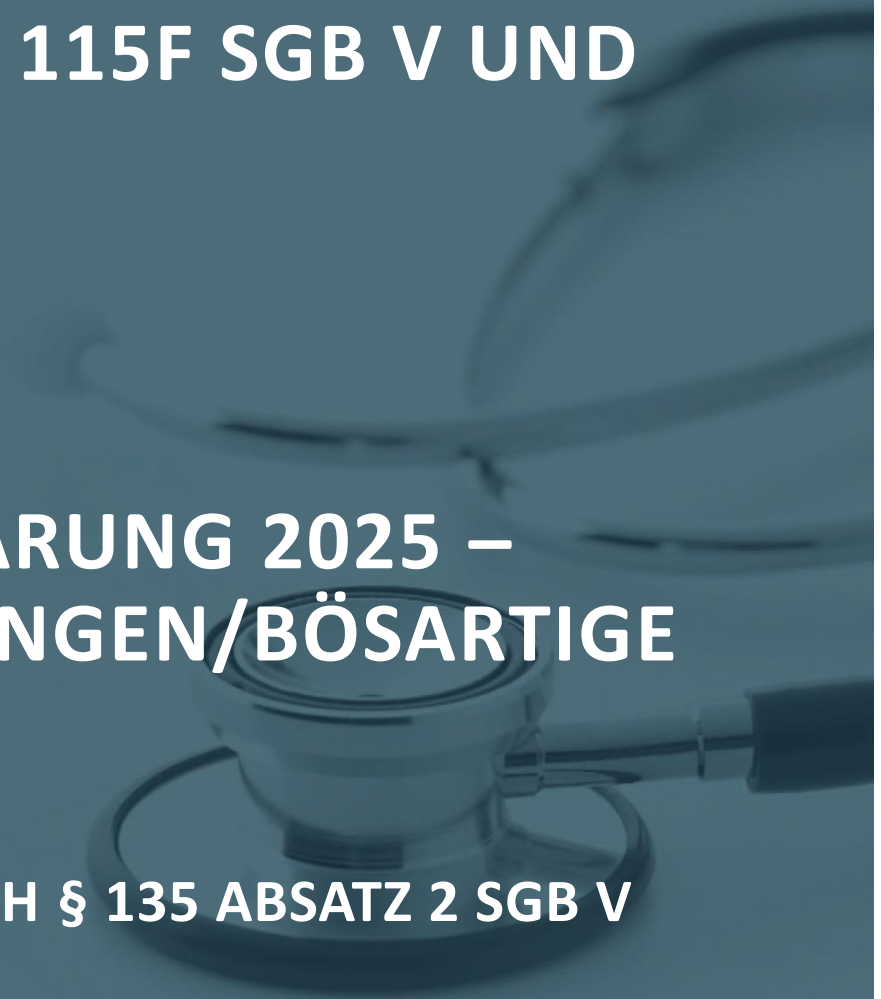
Vortrag: Hybrid DRG

AutorIn: Anna Maria Raskop, Berlin [6]

Offenlegung finanzieller Interessen:

[1]: BeraterIn (B):	Kommerzielle Vergütung oder Unterstützung der Autorin / des Autors in den letzten drei Jahren in Form von Beraterverträgen (Mitgliedschaft in Gremien, Beiräten, Aufsichtsräten etc.)
[2]: EigentümerIn (E):	Eigentümerinteresse an Arzneimittel/Medizinprodukten (z.B. Patent, Urheberrecht, Verkaufslizenz, etc.)
[3]: InvestorIn (I):	Finanzielles Interesse an Firmen, die eine beschriebene Ausrüstung, ein Verfahren oder Produkte liefern (z.B. Aktienbesitz, AnteilseignerIn etc.)
[4]: MitarbeiterIn (M):	Finanzielles Interesse bei der Produktvermarktung (MitarbeiterIn des Produktherstellers)
[5]: Produkt (P):	Finanzielles Interesse bei der Ausrüstung, dem beschriebenen Verfahren und/oder dem beschriebenen Produkt (z.B. Forschungsunterstützungen, Referentenhonorare, Reisekostenunterstützungen, Stipendien etc.)
[6]: Keine (K):	Keine Interessenskonflikte; keine kommerzielle Unterstützung der vorgelegten Arbeit in irgendeiner Form

- ZEITVORGABEN HYBRID-DRG NACH § 115F SGB V UND SACHSTAND
  - BEAUFTRAGUNG KATALOGERWEITERUNG
  - BEAUFTRAGUNG KALKULATION AB 2031
  - BEAUFTRAGUNG EVALUATION
  - BEAUFTRAGUNG VORSCHLAG KALKULATION 2026
- HYBRID-DRG-VERGÜTUNGSVEREINBARUNG 2025 – HISTOPATHOLOGISCHE UNTERSUCHUNGEN/BÖSARTIGE NEUBILDUNGEN
- SONSTIGES
  - QS-VEREINBARUNG AMBULANTES OPERIEREN NACH § 135 ABSATZ 2 SGB V



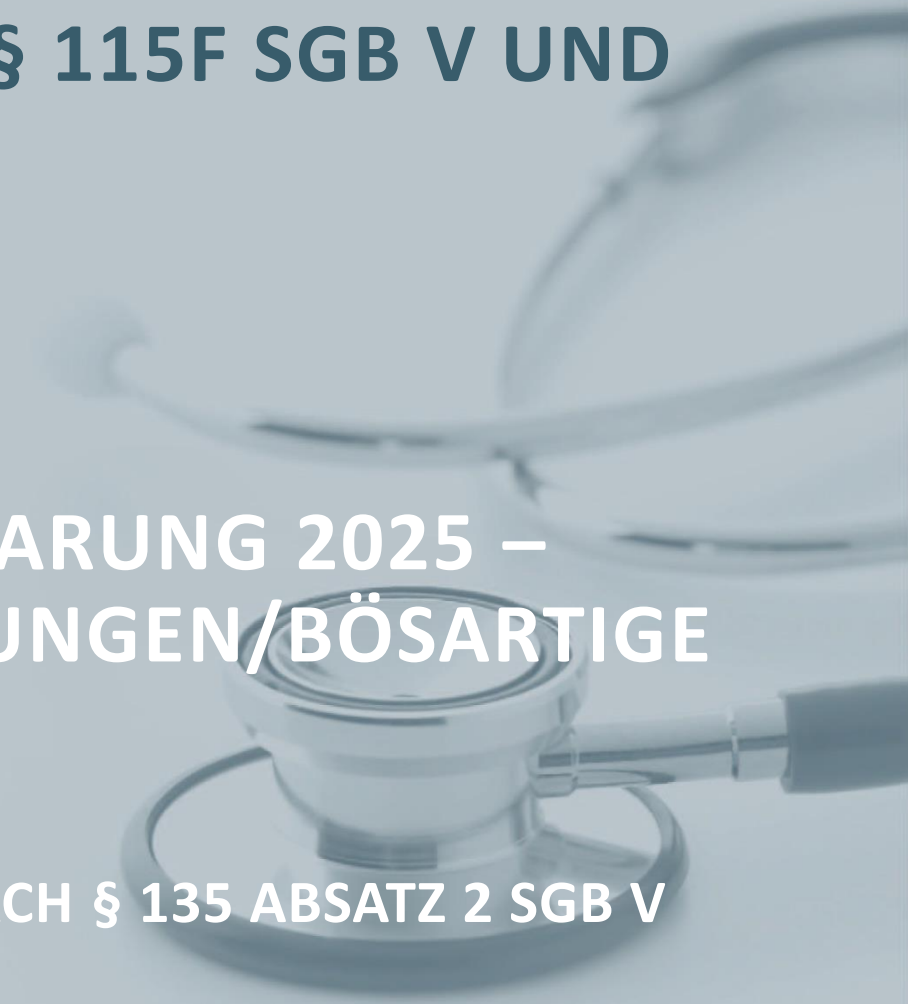
↗ ZEITVORGABEN HYBRID-DRG NACH § 115F SGB V UND SACHSTAND

- ↗ BEAUFTRAGUNG KATALOGERWEITERUNG
- ↗ BEAUFTRAGUNG KALKULATION AB 2031
- ↗ BEAUFTRAGUNG EVALUATION
- ↗ BEAUFTRAGUNG VORSCHLAG KALKULATION 2026

↗ HYBRID-DRG-VERGÜTUNGSVEREINBARUNG 2025 – HISTOPATHOLOGISCHE UNTERSUCHUNGEN/BÖSARTIGE NEUBILDUNGEN

↗ SONSTIGES

- ↗ QS-VEREINBARUNG AMBULANTES OPERIEREN NACH § 135 ABSATZ 2 SGB V



Zeitvorgaben Hybrid-DRG nach § 115f SGB V

- Gesetzgeber hat das Verhandlungsmodell für die Hybrid-DRG mit dem Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz (KHVVG) mit Wirkung zu 2025 deutlich verändert
  - Einbindung des ergänzten erweiterten Bewertungsausschusses (ergEBA) als Entscheidungsgremium
  - Einbindung/Beauftragung des Instituts für das Entgeltsystem im Krankenhaus (InEK) und des Instituts des Bewertungsausschusses (InBA) gemeinsam
  - Vorgabe von Mindestfallzahlen zur Ambulantisierung
  - Vorgaben zur Preisabsenkung im Zeitverlauf
  - Vorgabe einer engen Zeitschiene für die abzuschließenden Vereinbarungen

Zeitvorgaben Hybrid-DRG nach § 115f SGB V

- Katalogerweiterung
  - Beauftragung für Vorschlag bis 15. Februar 2025 - konnte nicht geeint werden, daher Ersatzvornahme durch Bundesministerium für Gesundheit (BMG)
  - Vereinbarung bis 31. März 2025 (ggf. ergEBA – Entscheidungsfindung innerhalb von vier Wochen ansonsten Festlegung durch BMG)

- Kalkulation ab 2031
  - Beauftragung Kalkulationskonzept mit empirischen Kostendaten bis 30. April 2025 (ggf. BMG)
  - Vereinbarung bis 31. Dezember 2025 (ggf. ergEBA innerhalb von vier Wochen sonst BMG)

- Kalkulation 2026
  - Beauftragung für Vorschlag bis 15. Mai 2025 (ggf. BMG)
  - Vereinbarung bis 30. Juni 2025 (ggf. ergEBA innerhalb von vier Wochen sonst BMG)

↗ ZEITVORGABEN HYBRID-DRG NACH § 115F SGB V UND SACHSTAND

- ↗ BEAUFTRAGUNG KATALOGERWEITERUNG
- ↗ BEAUFTRAGUNG KALKULATION AB 2031
- ↗ BEAUFTRAGUNG EVALUATION
- ↗ BEAUFTRAGUNG VORSCHLAG KALKULATION 2026

↗ HYBRID-DRG-VERGÜTUNGSVEREINBARUNG 2025 – HISTOPATHOLOGISCHE UNTERSUCHUNGEN/BÖSARTIGE NEUBILDUNGEN

↗ SONSTIGES

- ↗ QS-VEREINBARUNG AMBULANTES OPERIEREN NACH § 135 ABSATZ 2 SGB V



Beauftragung Katalogerweiterung

Rechtliche Vorgaben

- Dreiseitige Vertragspartner haben Auswahl der Leistungen jährlich zu überprüfen und bis zum 31. März des jeweiligen Jahres, in dem die Überprüfung stattfindet, mit Wirkung ab dem 1. Januar des folgenden Kalenderjahres anzupassen

- Auswahl hat so zu erfolgen, dass bezogen auf die gemäß § 21 Absatz 2 des Krankenhausentgeltgesetzes für das Jahr 2023 übermittelten Daten zu vollstationären Krankenhausfällen ohne Berücksichtigung der NUB-Fälle
  - ab 2026: jährlich mindestens 1 Mio. Fälle
  - ab 2028: jährlich mindestens 1,5 Mio. Fälle
  - ab 2030: jährlich mindestens 2 Mio. Fälle

  erfasst werden

Beauftragung Katalogerweiterung

Rechtliche Vorgaben

- Dreiseitige Vertragspartner beauftragen InEK und InBA gemeinsam bis zum 15. Februar eines jeden Kalenderjahres mit
  - Überprüfung der Auswahl der Leistungen
  - Vorlage eines Vorschlags zur Anpassung der Leistungsauswahl

- Bei der Überprüfung und Anpassung nach Satz 1 können auch Leistungen ausgewählt werden, die nicht im AOP-Katalog genannt sind

- Leistungen für Kinder, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, und Leistungen für Menschen mit Behinderungen sollen nicht ausgewählt werden

Beauftragung Katalogerweiterung

Ziele der KBV

- Deutliche Katalogerweiterung

- Stärkere Berücksichtigung der vertragsärztlichen Interessen bei der Leistungsauswahl
  - Keine Eingrenzung der Fälle auf 1 Übernachtung
  - Leistungsauswahl im Hinblick auf die Kalkulation unter Berücksichtigung der vertragsärztlichen Vergütung (z. B. Sachkosten siehe unten)
  - Stärkere Differenzierung der Hybrid-DRGs nach inhalts- und aufwandsgleichen OPS

- Eingrenzung der Autonomie des InEK bei der Festlegung der Leistungen

Beauftragung Katalogerweiterung

Vorgehen der KBV

- Ausgestaltung der Beauftragung im Sinne der Ziele der KBV mit folgenden Vorgaben und Fragestellungen
  - Auswahl der OPS-Kodes mit Berücksichtigung/Darlegung von Ein- und Ausschlusskriterien z. B.
    - Ambulantisierungsgrad mit Ausweis der Fallzahlen ambulant und stationär
    - Verweildauern bis zu drei Tagen bei stationären Fällen mit Fallzahlen
    - Zusatzentgelte
    - Abrechnung nach EBM
      - OP-Kategorie bzw. EBM-GOP
    - Begleitleistungen z. B.
      - pathologische Untersuchungen
      - Sachkosten

Beauftragung Katalogerweiterung

Aktueller Sachstand

- Dreiseitige Verhandlungen zur Beauftragung der Institute zur Erstellung eines Vorschlags zur Leistungsauswahl für den Hybrid-DRG-Katalog 2026 sind gescheitert
  - Konsens mit der DKG konnte zu den Auswahlkriterien nicht erzielt werden

Vorschlag GKV-SV und KBV	Vorschlag DKG
Für die Erfüllung der nach § 115f Absatz 2 Satz 2 vorgegebenen Fallzahlen sollen vorrangig Fälle mit einer niedrigen **Verweildauer bis maximal 3 Tage**, einem Ambulantisierungsgrad von maximal 50 % sowie einem PCCL von maximal 2 ausgewählt werden.	Für die Erfüllung der nach § 115f Absatz 2 Satz 2 vorgegebenen Fallzahlen soll **die Anzahl der Fälle mit einem Belegungstag**, einem Ambulantisierungsgrad von ≤ 50 % und einem PCCL ≤ 2 dargestellt werden.

Beauftragung Katalogerweiterung

Aktueller Sachstand

- BMG und Institute wurden am 13. Februar 2025 über das Scheitern der dreiseitigen Verhandlungen zur Beauftragung informiert

- Darstellung der jeweiligen Perspektiven wurden von den Vertragsparteien in einem separaten Schreiben an das BMG versendet
  - Ein geeinter Entwurf von KBV und GKV-SV wurde dem BMG am 17. Februar 2025 übermittelt
    - Basierend auf zunächst dreiseitig abgestimmter Beauftragung nach o. g. Auswahlkriterien
      - mit Forderung einer „Auswahl“ an OPS-Kodes, die über die gesetzliche Fallzahlforderung hinausgeht
      - mit detaillierten Vorgaben zur Aufbereitung der ausgewählten Leistungen mit Zusatzinformationen inkl. Sachkosten
      - mit Benennung von zweiseitig geeinten Leistungsbereichen, die von den Instituten dargestellt werden sollen

Beauftragung Katalogerweiterung

Aktueller Sachstand

- Am 24. Februar 2025 beauftragte das BMG in einem Schreiben das InEK und InBA zur Überprüfung der Leistungsauswahl und Vorlage eines Vorschlags zur Anpassung der Leistungsauswahl für 2026
  - Der Vorschlag soll den Vertragsparteien vor dem 31. März 2025 vorgelegt werden
  - Das BMG verweist zu den Kriterien der Beauftragung auf den Normtext von § 115f Absatz 2 Satz 2 und 5 SGB V:
    - Datengrundlage: Datenübermittlung nach § 21 Absatz 2 KHEntgG für das Jahr 2023
    - Mindestens eine Million Fälle
    - Keine Krankenhausfälle, in denen neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden angewendet werden
    - Keine Leistungen für Kinder unter 18 Jahren
    - Keine Leistungen für Menschen mit Behinderungen

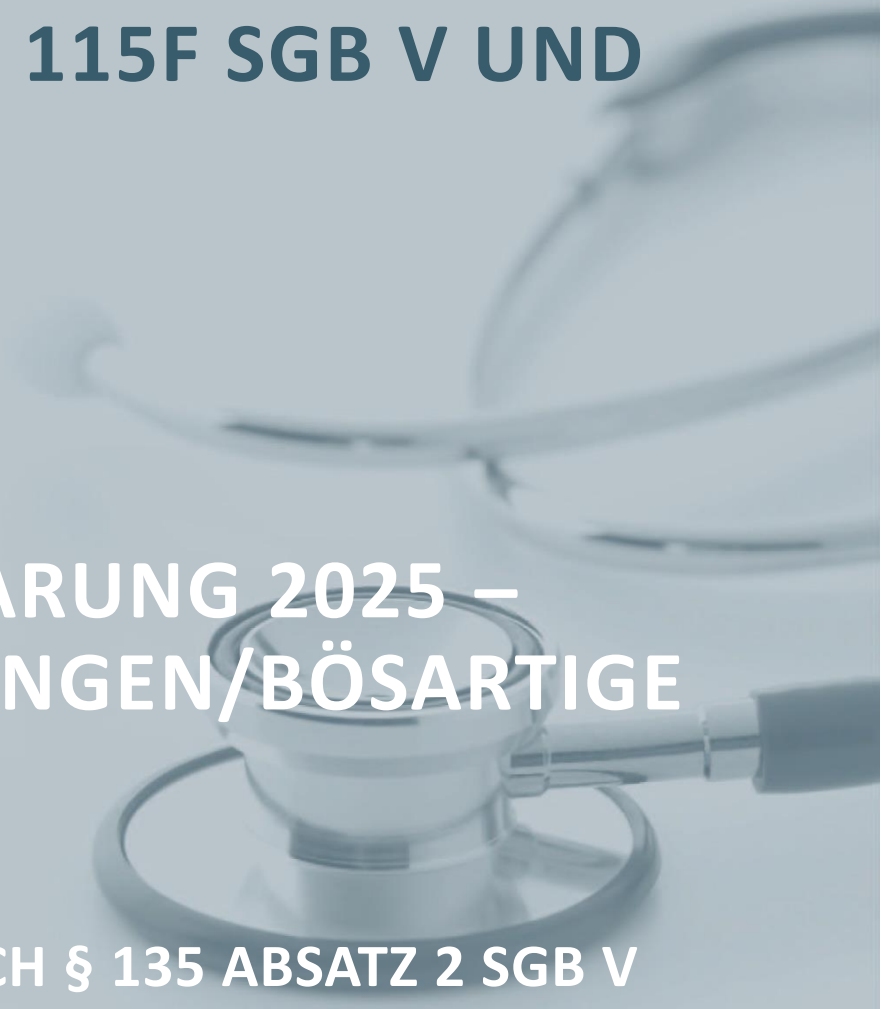
↗ ZEITVORGABEN HYBRID-DRG NACH § 115F SGB V UND SACHSTAND

- ↗ BEAUFTRAGUNG KATALOGERWEITERUNG
- ↗ BEAUFTRAGUNG KALKULATION AB 2031
- ↗ BEAUFTRAGUNG EVALUATION
- ↗ BEAUFTRAGUNG VORSCHLAG KALKULATION 2026

↗ HYBRID-DRG-VERGÜTUNGSVEREINBARUNG 2025 – HISTOPATHOLOGISCHE UNTERSUCHUNGEN/BÖSARTIGE NEUBILDUNGEN

↗ SONSTIGES

- ↗ QS-VEREINBARUNG AMBULANTES OPERIEREN NACH § 135 ABSATZ 2 SGB V



Beauftragung Kalkulation ab 2031

Rechtliche Vorgaben

- Fallpauschalen sind spätestens ab 2031 auf Grundlage fallbezogener empirischer Kostendaten des ambulanten und stationären Bereichs festzulegen
- Anschließend jährliche Überprüfung auf Grundlage aktueller Kostendaten und sofern erforderlich Anpassung
- Beauftragung InEK und InBA gemeinsam bis zum 30. April 2025 zur Erarbeitung eines Vorschlags für ein Konzept zur Festlegung der Fallpauschalen
- Vertragspartner vereinbaren auf dieser Grundlage bis zum 31. Dezember 2025 das Konzept zur Festlegung der Fallpauschalen ab 2031

Beauftragung Kalkulation ab 2031

Geplantes Vorgehen der KBV

- Entwicklung eines stufenweisen Beauftragungskonzeptes
  - Allgemeiner Auftrag bis 30. April 2025 zur Beantwortung grundsätzlicher Fragestellungen
  - Weitere konkretisierende Beauftragungen im Anschluss in regelmäßigem Austausch mit den Instituten

- Kassenärztliche Vereinigungen und Zentralinstitut für die vertragsärztliche Versorgung (Zi) prüfen mit ambulanten Operateuren vorab die Möglichkeiten einer Teilnahme von ambulanten Praxen und OP-Zentren an einer Erhebung

↗ ZEITVORGABEN HYBRID-DRG NACH § 115F SGB V UND SACHSTAND

- ↗ BEAUFTRAGUNG KATALOGERWEITERUNG
- ↗ BEAUFTRAGUNG KALKULATION AB 2031
- ↗ BEAUFTRAGUNG EVALUATION
- ↗ BEAUFTRAGUNG VORSCHLAG KALKULATION 2026

↗ HYBRID-DRG-VERGÜTUNGSVEREINBARUNG 2025 – HISTOPATHOLOGISCHE UNTERSUCHUNGEN/BÖSARTIGE NEUBILDUNGEN

↗ SONSTIGES

- ↗ QS-VEREINBARUNG AMBULANTES OPERIEREN NACH § 135 ABSATZ 2 SGB V



Beauftragung Evaluation

Rechtliche Vorgaben

- Beauftragung InEK und InBA auf der Grundlage nicht personenbezogener Leistungsdaten mit der regelmäßigen Evaluation der Auswirkungen der speziellen sektorengleichen Vergütung auf
  - die Versorgung der Versicherten
  - die Vergütungen der Leistungserbringer
  - die Ausgaben der Krankenkassen

- Evaluationsbericht ist dem BMG alle 18 Monaten, erstmals zum 30. Juni 2026, vorzulegen

Beauftragung Evaluation

Geplantes Vorgehen der KBV

- Beauftragung zur Evaluation ohne Vorgabe durch ein dreiseitig zu einendes Konzept
  - Aus Sicht der KBV sachgerechtes Vorgehen, da in etwaigen dreiseitigen Beratungen zu einem Evaluationskonzept kein Nutzen für die Vertragsärzte gesehen wird

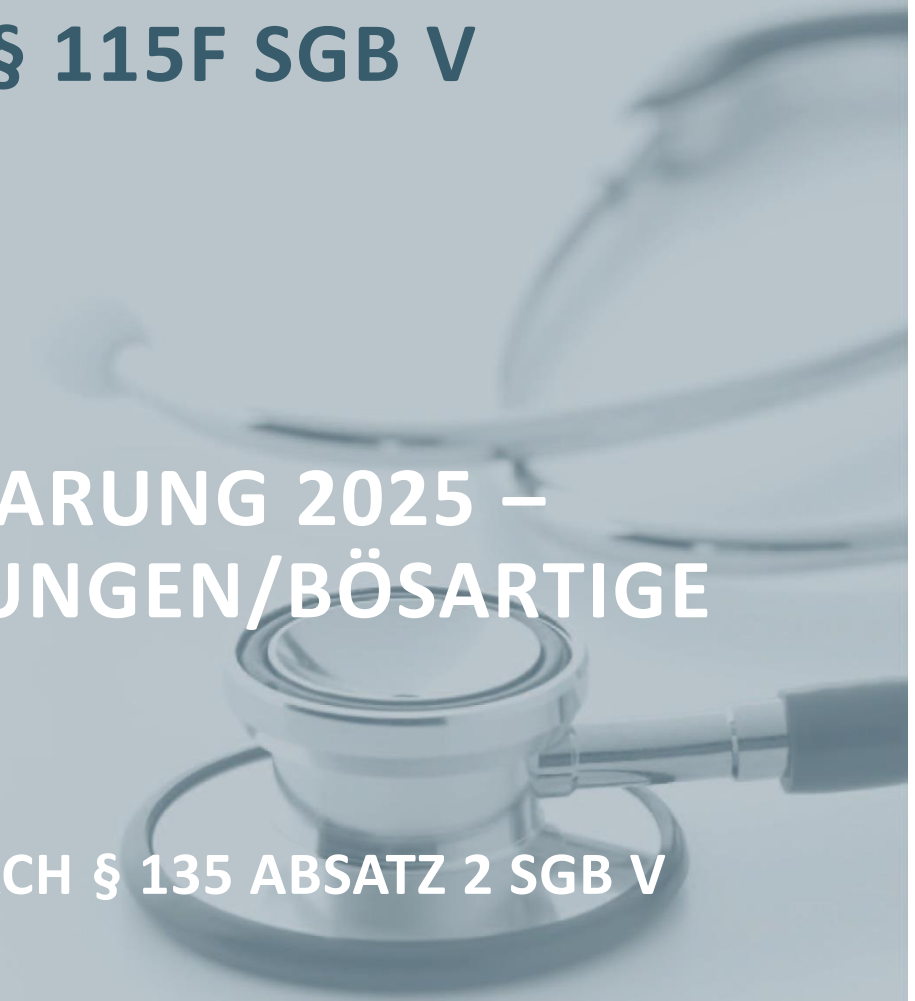
↗ ZEITVORGABEN HYBRID-DRG NACH § 115F SGB V

- ↗ BEAUFTRAGUNG KATALOGERWEITERUNG
- ↗ BEAUFTRAGUNG KALKULATION AB 2031
- ↗ BEAUFTRAGUNG EVALUATION
- ↗ BEAUFTRAGUNG VORSCHLAG KALKULATION 2026

↗ HYBRID-DRG-VERGÜTUNGSVEREINBARUNG 2025 – HISTOPATHOLOGISCHE UNTERSUCHUNGEN/BÖSARTIGE NEUBILDUNGEN

↗ SONSTIGES

- ↗ QS-VEREINBARUNG AMBULANTES OPERIEREN NACH § 135 ABSATZ 2 SGB V



Beauftragung Vorschlag Kalkulation 2026

Rechtliche Vorgaben

- Vertragsparteien vereinbaren spezielle sektorengleiche Vergütung unabhängig davon,
  - ob die vergütete Leistung ambulant oder stationär mit Übernachtung erbracht wird
  - für welche der im Katalog genannten Leistungen die Vergütung als Hybrid-DRG erfolgt

- Vergütung erfolgt als Fallpauschale, Schweregradunterschiede der Fälle sind durch Stufen zu berücksichtigen

- Erstmalige Kalkulation auf Basis der im stationären und ambulanten Bereich, für das zum Zeitpunkt der Kalkulation letzte Abrechnungsjahr gezahlten Vergütungsvolumina sowie der Anzahl der erbrachten Fälle

Beauftragung Vorschlag Kalkulation 2026

Rechtliche Vorgaben

- Krankenkassen übermitteln an InEK und InBA, auf Anforderung innerhalb von zwei Wochen, die für das letzte vollständige Abrechnungsjahr verfügbaren Fallzahlen und Vergütungen
  - bezogen auf die ausgewählten Leistungen nach OPS-Kodes unter Angabe der Sachkosten

- Dreiseitige Vertragspartner beauftragen InEK und InBA gemeinsam bis zum 15. Mai eines jeden Kalenderjahres, einen Vorschlag für die Kalkulation differenziert nach dem Schweregrad der Fälle sowie mit schrittweiser Anpassung der Vergütungen zu erarbeiten
  - Ziel, bis 2030 die Vergütungshöhe der nach § 115b SGB V vereinbarten Leistungen (EBM-Niveau) zu erreichen

- Auf Grundlage des Vorschlags schließen die dreiseitigen Vertragspartner die Hybrid-DRG-Vereinbarung bis zum 30. Juni jeden Jahres mit Wirkung ab dem 1. Januar des folgenden Jahres

Beauftragung Vorschlag Kalkulation 2026

Ziele der KBV

- Stärkere Berücksichtigung der vertragsärztlichen Interessen
  - Stärkere Differenzierung der Vergütung der Hybrid-DRG
  - Sachgerechte Berücksichtigung der Höhe der Sachkosten

- Keine Eingrenzung auf Kosten der Fälle mit 1 Übernachtung

Beauftragung Vorschlag Kalkulation 2026

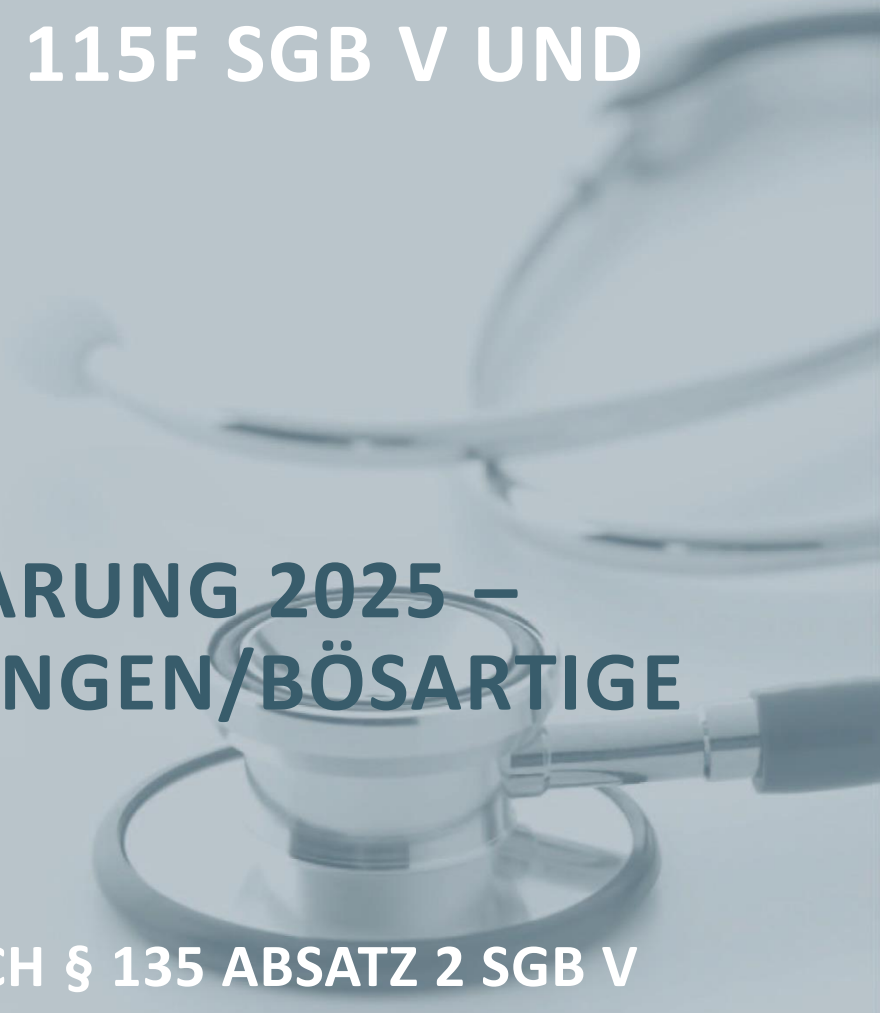
Geplantes Vorgehen der KBV

- Differenzierung der Hybrid-DRG nach Schweregrad z. B.
  - über stärkere Berücksichtigung der EBM-Kategorie der jeweiligen Eingriffe (Anhang 2 EBM)
  - weitere Differenzierung nach PCCL (über DRG-Grouper hinaus)

  → Auftrag an die Institute zur Prüfung

- Schrittweise Anpassung der Vergütungen auf EBM-Niveau
  - Überlegungen zu politischen Aktivitäten zur Anpassung der Rechtslage
  - Prüfung der geplanten STABS-Weiterentwicklung (EBM-Kalkulation), um diese ggf. in dreiseitige Verhandlung einzubringen (Kalkulation ab 2031)

- ZEITVORGABEN HYBRID-DRG NACH § 115F SGB V UND SACHSTAND
  - BEAUFTRAGUNG KATALOGERWEITERUNG
  - BEAUFTRAGUNG KALKULATION AB 2031
  - BEAUFTRAGUNG EVALUATION
  - BEAUFTRAGUNG VORSCHLAG KALKULATION 2026
- HYBRID-DRG-VERGÜTUNGSVEREINBARUNG 2025 – HISTOPATHOLOGISCHE UNTERSUCHUNGEN/BÖSARTIGE NEUBILDUNGEN
- SONSTIGES
  - QS-VEREINBARUNG AMBULANTES OPERIEREN NACH § 135 ABSATZ 2 SGB V



Hybrid-DRG-Vergütungsvereinbarung 2025 – Histopathologische Untersuchungen/Bösartige Neubildungen

- Hybrid-DRG-Vergütungsvereinbarung § 5 Absatz 5 Leistungen, die nicht zusätzlich zu einer Fallpauschale abrechenbar sind; Punkt 6:
  - Histopathologische und zytologische Beurteilung von intraoperativ entnommenen Materials gemäß Indikation und diagnostischer und therapeutischer Fragestellung

- Keine klare Abgrenzung der Leistungen gemäß EBM-Logik

- Sprachregelung auf die sich seitens der KBV mit den KVen verständigt werden konnte:
  - *Bestandteil der Hybrid-DRG ist die erste Untersuchung zur histopathologischen und zytologischen Beurteilung von intraoperativ entnommenem Material. Weiterführende Untersuchungen der Tumordiagnostik, u. a. zur Therapieentscheidung unter Beteiligung weiterer nichtoperativer Fachgruppen, wären nach dem EBM berechnungsfähig und nicht Bestandteil der H-DRG.*

Hybrid-DRG-Vergütungsvereinbarung 2025 – Histopathologische Untersuchungen/Bösartige Neubildungen

- Die Hybrid-DRG-Definitionen für 2024 und 2025 enthalten die Bedingung „Ausschluss Kontextfaktoren“ (globale Funktion in der DRG-Definition)
  - Dann wird die Hybrid-DRG im Gruppierungsprozess nicht ausgelöst

- 2024 bestanden bei allen Hybrid-DRG **einheitliche** Kontextfaktorenlisten mit bösartigen Neubildungen als Haupt- oder Nebendiagnose

- 2025 sind **je nach** Hybrid-DRG weitere **spezifische** Kontextfaktorenlisten definiert
  - Dadurch ist das Vorliegen einer bösartigen Neubildung nicht unbedingt ein Ausschlusskriterium

Hybrid-DRG-Vergütungsvereinbarung 2025 – Histopathologische Untersuchungen/Bösartige Neubildungen

- Für folgende Hybrid-DRG ist das Vorliegen einer bösartigen Neubildung nicht unbedingt ein Ausschlusskriterium:
  - E02N
  - Q03N
  - R14N

  } C00 – C97 kein „Kontextfaktor“
  H-DRG hauptsächlich für Biopsien an den Lymphknoten

  - L20M
  - L20N

  } C67.- kein „Kontextfaktor“
  im Zusammenhang mit TUR-B

Best. transurethrale Eingriffe an der Harnblase (L20-V24)

1-460.2	Transurethrale Biopsie Harnblase	5-573.32	Transurethr Destr (erkr) Gew Harnblase d Elektrokoagulation
5-573.0	Transurethrale Inzision v (erkrankt) Gewebe Harnblase	5-573.3x	Sonstige transurethr Destr (erkr) Gewebe Harnblase
5-573.20	Transurethr Exzis (erkr) Gew Harnblase: Nicht fluoreszenzgest	5-573.40	Transureth Resek (erkr) Gew Harnbl, nicht fluoreszenzgestützt
5-573.21	TrUrethr Exz Gew Harnbl: FluoreszGest Hexaminolävulinsäure	5-573.41	Transureth Resek (erkr) Gew Harnbl, fluoreszenzgest m HAL
5-573.2x	Transurethr Exzis (erkr) Gew Harnblase: Fluoreszgest so Subst	5-573.4x	Transureth Resek (erkr) Gew Harnbl, fluoreszgest m so Subs
5-573.30	Transurethr Destr (erkr) Gew Harnblase d Radiofrequenzabl	5-573.x	So transur Inz, Exz, Destr u Res (erkr) Gew Harnbl
5-573.31	Transurethr Destr (erkr) Gew Harnblase d Mikrowellenablation	5-573.y	Transur Inz, Exz, Destr u Res (erkr) Gew Harnbl, nnbez

Beispiel 1: Gruppierung in eine Hybrid-DRG bei bösartiger Neubildung

Es erfolgt die CT-gestützte perkutane Biopsie eines vergrößerten mediastinalen Lymphknotens. Histopathologisch ergibt sich die Lymphknotenmetastase eines Bronchialkarzinoms.

- Daten für den Grouper:
  - Hauptdiagnose: C77.1 - Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Intrathorakale Lymphknoten
  - Prozedur: 1-426.3 - (Perkutane) Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Lymphknoten, mediastinal
  - Verweildauer: 1, Beatmungsstunden: 0

- Gruppierungsergebnis: R14N – Hybrid-DRG der DRG R14Z
  - R14Z: Andere hämatologische und solide Neubildungen mit anderen OR-Prozeduren ohne äußerst schwere oder schwere CC oder Therapie mit offenen Nukliden bei hämatologischen und soliden Neubildungen, mehr als ein Belegungstag

Verwendeter Grouper: Webgrouper der DRG-Research-Group

Beispiel 2: Gruppierung in eine Hybrid-DRG bei bösartiger Neubildung

Es erfolgt die fluoreszenzgestützte (Hexaminolävulinsäure) Resektion von erkranktem Gewebe des Trigonum vesicae bei einem 75-jährigen Mann. Histopathologisch ergibt sich ein Harnblasenkarzinom.

- Daten für den Grouper:
  - Hauptdiagnose: C67.0 - Bösartige Neubildung: Trigonum vesicae
  - Prozedur: 5-573.41 - Transurethrale Inzision, Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Harnblase: Resektion: Fluoreszenzgestützt mit Hexaminolävulinsäure
  - Verweildauer: 1, Beatmungsstunden: 0, Alter: 75

- Gruppierungsergebnis: L20N – Hybrid-DRG der DRG L20B
  - L20B: Transurethrale Eingriffe außer Prostataresektion und komplexe Ureterorenoskopien oder bestimmte Eingriffe an den Harnorganen, ohne äußerst schwere CC oder Alter < 16 Jahre oder Alter > 89 Jahre

Verwendeter Grouper: Webgrouper der DRG-Research-Group

Vergütung der histopathologischen Untersuchungen/bösartiger Neubildungen mit Hybrid-DRG als Gruppierungsergebnis

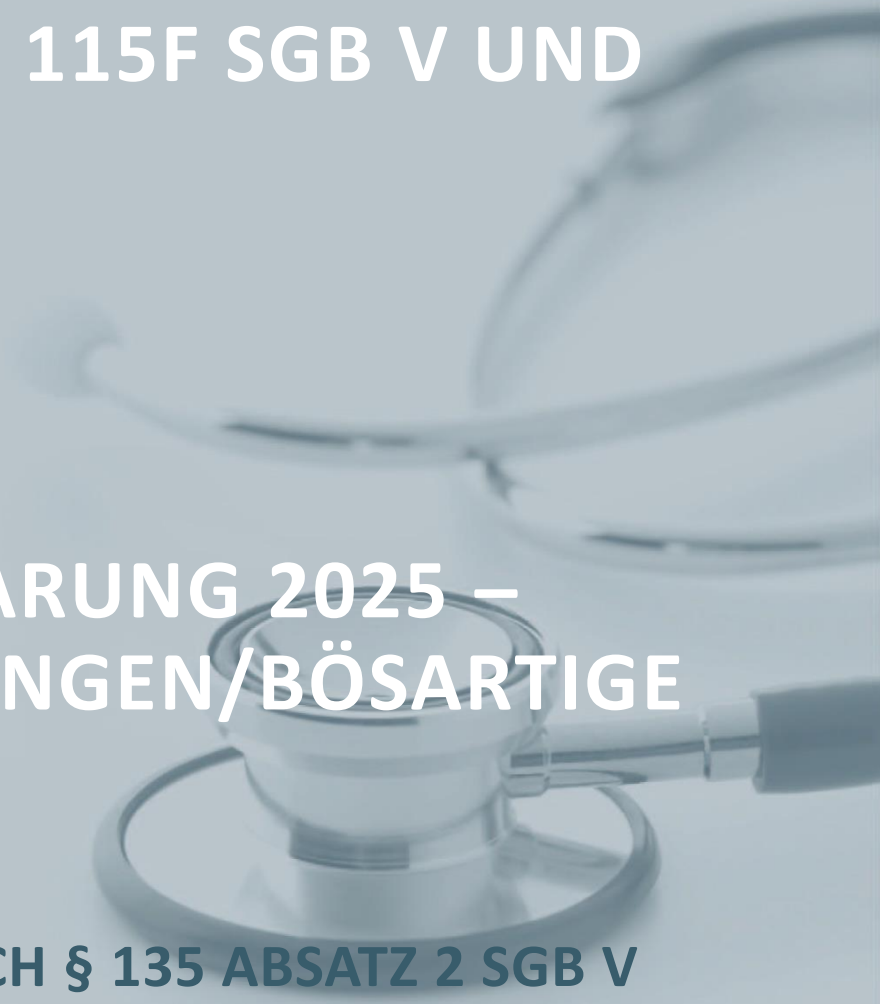
Option 1: Sprachregelung gegenüber Krankenkasse des Falls in Rechnung stellen

- Ist das möglich?

Option 2: Umsetzung der Sprachregelung in dreiseitiger Hybrid-DRG-Vereinbarung auf Bundesebene

- Hohes Risiko, dass Sprachregelung nicht einigungsfähig ist: Entscheidung des ergänzten erweiterten Bewertungsausschusses oder Ersatzvornahme des BMG ungewiss

- ZEITVORGABEN HYBRID-DRG NACH § 115F SGB V UND SACHSTAND
  - BEAUFTRAGUNG KATALOGERWEITERUNG
  - BEAUFTRAGUNG KALKULATION AB 2031
  - BEAUFTRAGUNG EVALUATION
  - BEAUFTRAGUNG VORSCHLAG KALKULATION 2026
- HYBRID-DRG-VERGÜTUNGSVEREINBARUNG 2025 – HISTOPATHOLOGISCHE UNTERSUCHUNGEN/BÖSARTIGE NEUBILDUNGEN
- SONSTIGES
  - QS-VEREINBARUNG AMBULANTES OPERIEREN NACH § 135 ABSATZ 2 SGB V



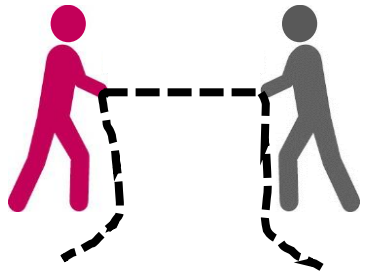
Überarbeitung Qualitätssicherungsvereinbarung Ambulantes Operieren nach § 135 Absatz 2 SGB V

- Beratungen mit dem GKV-SV laufen

- Hohe Anforderungen der Kassenseite
  - Einführung eines einrichtungsübergreifenden Fehlermeldesystems
  - Vorgaben für vorzuhaltendes Fachpersonal z. B. Krankenhaushygieniker
  - Konkretisierung der Hygiene-Anforderungen

- Position der KBV: Minimale Anpassung der QS-Vereinbarung Ambulantes Operieren vor dem Hintergrund geltender Vorschriften bzw. Empfehlungen z. B. gemäß KRINKO-Empfehlungen

- Bis zur Einigung gilt die QS-Vereinbarung Ambulantes Operieren weiter



DEUTSCHLAND MUSS #PRAXENLAND BLEIBEN

Praxenland.de